

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen sozialrecht-schwerbehindertenverfahren-gdb-merkzeichen-muenster

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 10_fristen_und_anlagen.csv

Ereignis	Datum	Notiz
Erhöhungsantrag	2026-03-04	GdB-Erhöhung und Merkzeichen G beantragt
Versorgungsärztliche Stellungnahme	2026-06-12	laut Akteneinsicht; nach Aktenlage
Bescheid	2026-06-21	GdB bleibt 30; Merkzeichen G abgelehnt
Zugang Bescheid	2026-06-25	Briefkasten; Umschlag in Handakte
Mandatserteilung	2026-07-01	Erstgespräch und Vollmacht
Widerspruch eingelegt	2026-07-03	vorab per Telefax; mit Akteneinsichtsantrag
Widerspruchsfrist rechnerisch	2026-07-25	Samstag; Fristende daher 2026-07-27
Widerspruchsfrist notiert	2026-07-27	Montag; Vorfrist 2026-07-13
Hausarztbericht	2026-06-28	liegt vor
Neurologiebericht	2026-06-10	liegt vor
Pneumologiebericht	2026-05-18	liegt vor
Arbeitsplatznotiz	2026-06-27	liegt vor
Orthopädiebericht	2026-07-08	liegt vor; nachgereicht am 2026-07-10
Akteneinsicht gewährt	2026-07-14	Kopie versorgungsärztliche Stellungnahme erhalten
Ergänzende Widerspruchsbegründung	2026-07-31	Wiedervorlage; nach Auswertung Akteneinsicht

Datei: 91_fristsaachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Bescheidzugang;prüfen;Briefumschlag oder Postvermerk fehlt häufig;Fristkalender		
medizinischer Kernbefund;prüfen;Arztbrief	Gutachten	Pflegeprotokoll;Belegmatrix
Eilbedürftigkeit;prüfen;Kosten	Gesundheitsrisiko	Versorgungslücke;Eilantrag oder Widerspruchsbegründung

Mandatsnotiz und Fristsache

Kanzlei Terwiel & Brandhove Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte PartG mbB

Salzstraße 21, 48143 Münster

Telefon 0251 41 88 02-0, Telefax 0251 41 88 02-29

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Dr. Sabine Terwiel, Fachanwältin für Sozialrecht

Aktenzeichen intern: 2026-0412-SB/te

Erstgespräch: 01.07.2026, 14:30 Uhr, anwesend die Mandantin

Mandantin

Helga Bertram, geboren am 22.05.1964, wohnhaft Zum Roten Berge 14, 48165 Münster-Hiltrup. Verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Beschäftigt als Küchenhilfe bei der Schulverpflegung Westfalen gGmbH, Einsatzort Schulzentrum Hiltrup, 24 Wochenstunden. Bekannter GdB 30 seit Bescheid vom 09.11.2021 wegen Diabetes mellitus mit Polyneuropathie und Wirbelsäulenbeschwerden.

Verfahrensstand und Frist

Erhöhungsantrag (Neufeststellung nach § 152 SGB IX) vom 04.03.2026, zugleich Antrag auf Merkzeichen G. Bescheid der Stadt Münster, Amt für Soziales und Wohnen, vom 21.06.2026, Geschäftszeichen 50.33-SB-2021-004718: GdB weiterhin 30, Merkzeichen G abgelehnt. Zugang nach Angabe der Mandantin am 25.06.2026, der Briefumschlag liegt in der Handakte.

Die Mandantin hat sich als Fristende den 25.07.2026 notiert. Das ist ein Samstag; das Fristende fällt damit auf Montag, den 27.07.2026. Eingetragen im Fristenkalender mit Vorfrist 13.07.2026.

Gesundheitliche Entwicklung seit 2021

Nach Schilderung der Mandantin und den mitgebrachten Unterlagen: diabetische Polyneuropathie mit brennenden Fußschmerzen beidseits, seit Ende 2025 deutlich zunehmend; COPD Gold II mit Belastungsdyspnoe, Erstdiagnose 2023, dem Versorgungsamt bis zum Erhöhungsantrag nicht gemeldet; Gonarthrose rechts mit Schwellneigung; rezidivierende depressive Anpassungsstörung, hausärztlich mitbehandelt. Die Mandantin gibt an, maximal 300 bis 400 Meter am Stück gehen zu können, dann brauche sie eine Pause. Am 18.04.2026 Sturz auf dem Weg zur Bushaltestelle.

Der Hausarzt Dr. Büscher befürwortet GdB 50 und Merkzeichen G. Das Versorgungsamt stützt sich nach dem Bescheidtext im Wesentlichen auf kurze Befundantworten; aktuelle Lungenfunktionswerte lagen der Verwaltung offenbar nicht vor.

Auftrag und Vorgehen

Widerspruch fristwährend einlegen, Begründung nach Akteneinsicht ergänzen.

Akteneinsicht in den Verwaltungsvorgang beantragen, insbesondere in die versorgungsärztliche Stellungnahme.

Befunde gezielt nachreichen: Hausarzt, Neurologie, Pneumologie, Orthopädie, Arbeitsplatz.

Nicht vorschnell Diagnosen addieren; entscheidend sind Funktionsbeeinträchtigungen, Teilhabefolgen, Gehfähigkeit, Schmerz, Atemnot, Arbeitsplatzbelastung und die Konsistenz der ärztlichen Angaben untereinander.

Perspektive besprechen: Bei einem GdB von 50 käme später die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Betracht; die Mandantin ist Jahrgang 1964.

Kostenhinweis

Beratungshilfe kommt wegen des Erwerbseinkommens beider Eheleute nicht in Betracht.
Vergütungsvereinbarung für das Widerspruchsverfahren am 01.07.2026 unterzeichnet; auf die Erstattungsregelung des § 63 SGB X wurde hingewiesen. Eine Rechtsschutzversicherung besteht nicht.

Bescheid der Stadt Münster über die Neufeststellung

Stadt Münster

Amt für Soziales und Wohnen

Sachgebiet Schwerbehindertenrecht

Hafenstraße 8, 48153 Münster

Telefon 0251 4 92-50 33

Geschäftszeichen: 50.33-SB-2021-004718 (bitte stets angeben)

Sachbearbeitung: Frau Kottrup, Zimmer 214

Münster, den 21.06.2026

Frau

Helga Bertram

Zum Roten Berge 14

48165 Münster

Ihr Antrag vom 04.03.2026 auf Neufeststellung nach § 152 Abs. 1 SGB IX und auf Feststellung des Merkzeichens G

Sehr geehrte Frau Bertram,

auf Ihren Antrag vom 04.03.2026 haben wir die gesundheitlichen Verhältnisse erneut geprüft. Wir haben Befundberichte Ihrer behandelnden Ärzte eingeholt und versorgungsärztlich auswerten lassen.

1 Entscheidung

1.1 Der Grad der Behinderung (GdB) beträgt weiterhin 30.

1.2 Die gesundheitlichen Voraussetzungen für das Merkzeichen G (erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr) liegen nicht vor.

2 Begründung

Bei der Beurteilung wurden folgende Funktionsbeeinträchtigungen berücksichtigt:

Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) mit nervalen Beschwerden,

Funktionsbeeinträchtigung der Wirbelsäule,

Atemwegsbeschwerden,

Funktionsbeeinträchtigung des rechten Kniegelenks.

Nach dem Ergebnis der versorgungsärztlichen Auswertung der eingeholten Befundberichte ist gegenüber der letzten Feststellung vom 09.11.2021 keine wesentliche Änderung der gesundheitlichen Verhältnisse eingetreten. Die einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen sind nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen (Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung) bewertet worden. Der Gesamt-GdB ist nicht durch Addition der Einzelwerte, sondern nach den Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit gebildet worden. Er beträgt weiterhin 30.

Das Merkzeichen G setzt voraus, dass die Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, das heißt, dass Wegstrecken im Ortsverkehr, die üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden, nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder Gefahren bewältigt werden können. Nach den vorliegenden

ärztlichen Unterlagen ist Ihre Gehfähigkeit nicht in einem Ausmaß eingeschränkt, das diesen Anforderungen entspricht.

3 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Münster, Amt für Soziales und Wohnen, Hafenstraße 8, 48153 Münster, einzulegen. Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei einer anderen inländischen Behörde, einem Versicherungsträger oder einer deutschen Konsularbehörde eingeht.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Kottrup

Befundbericht des Hausarztes

Praxis Dr. med. Bernhard Büscher

Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologe DDG

Marktallee 52, 48165 Münster-Hiltrup

Telefon 02501 92 44 10, Telefax 02501 92 44 11

Münster, den 28.06.2026

An die

Kanzlei Terwiel & Brandhove

Salzstraße 21

48143 Münster

Befundbericht Helga Bertram, geboren am 22.05.1964, auf Anforderung vom 26.06.2026 mit
Schweigepflichtentbindung

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Terwiel,

Frau Bertram ist seit 2009 in meiner hausärztlichen Behandlung. Zum aktuellen Gesundheitszustand
berichte ich wie folgt.

Diagnosen

Diabetes mellitus Typ 2, insulinpflichtig seit 2018, wechselhaft eingestellt (HbA1c zuletzt 8,1 Prozent am
03.06.2026, davor 7,4 Prozent im Januar 2026).

Diabetische sensomotorische Polyneuropathie beider Beine, deutlich progredient seit Ende 2025.

COPD Gold II, pneumologisch mitbehandelt.

Gonarthrose rechts mit Schwellneigung nach Belastung.

Chronisches Lumbalsyndrom bei degenerativen Veränderungen L4/L5.

Rezidivierende depressive Anpassungsstörung, derzeit ohne fachpsychiatrische Behandlung.

Verlauf und Befund

Der Diabetes ist trotz intensivierter Insulintherapie wechselhaft eingestellt. Seit Ende 2025 beobachte ich
eine deutliche Zunahme der neuropathischen Beschwerden beider Füße mit Brennen, Taubheitsgefühl
und Gangunsicherheit. Die Patientin vermeidet längere Wege und setzt sich bei Einkäufen häufig hin. Am
18.04.2026 stürzte sie auf dem Weg zur Bushaltestelle; ich habe ein ausgedehntes Hämatom am rechten
Knie dokumentiert, eine Fraktur lag nicht vor.

Die COPD ist pneumologisch gesichert; die letzte Spirometrie vom 18.05.2026 ergab eine FEV1 von 58
Prozent des Sollwertes. Es besteht Belastungsdyspnoe beim Treppensteigen und bei schnellerem Gehen.
Das rechte Knie schwillt nach längerer Steh- und Gehbelastung an.

Medikation

Insulin glargin abends, Insulin aspart zu den Mahlzeiten, Metformin 1000 mg zweimal täglich, Pregabalin
150 mg abends, Metamizol 500 mg bei Bedarf, LABA/LAMA-Inhalation, Salbutamol-Bedarfsspray. Unter
Pregabalin und Metamizol berichtet die Patientin über Müdigkeit und Benommenheit am Morgen.

Bewertung

Aus meiner Sicht ist der bisherige GdB von 30 zu niedrig. Die Kombination aus fortgeschrittener Polyneuropathie, COPD und Gonarthrose führt im Alltag zu einer erheblichen Einschränkung der Gehfähigkeit; hinzu kommt die dämpfende Wirkung der Schmerzmedikation. Ich befürworte einen GdB von 50 und das Merkzeichen G. Eine fachärztliche neurologische und pneumologische Ergänzung halte ich für sinnvoll; die entsprechenden Berichte von Frau Dr. Stern und dem Pneumologiezentrum Münster liegen Ihnen nach meiner Kenntnis bereits vor.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med. Bernhard Büscher

Neurologischer Bericht

Neurologische Praxis Dr. med. Aylin Stern

Fachärztin für Neurologie

Von-Vincke-Straße 9, 48143 Münster

Telefon 0251 39 55 27-0

Münster, den 10.06.2026

An Herrn Dr. med. Bernhard Büscher, Marktallee 52, 48165 Münster-Hiltrup

Bericht über Ihre Patientin Helga Bertram, geboren am 22.05.1964, Vorstellung am 08.06.2026 auf Ihre Überweisung

Sehr geehrter Herr Kollege Büscher,

vielen Dank für die Überweisung Ihrer Patientin zur Beurteilung der Polyneuropathie und der Gangunsicherheit.

Anamnese

Frau Bertram schildert brennende Schmerzen beider Füße, beginnend am späten Nachmittag und in der Nacht zunehmend, dazu Kribbelparästhesien und dadurch bedingte Einschlafstörungen. Die Gehstrecke gibt sie mit etwa 300 Metern ohne Pause an, bei Kälte weniger. Am 18.04.2026 sei sie auf dem Weg zur Bushaltestelle gestürzt (Hämatom am rechten Knie). Sie arbeite als Küchenhilfe und habe zunehmend Mühe, die Steh- und Gehanteile der Tätigkeit durchzuhalten.

Klinischer Befund

Distal symmetrische Sensibilitätsminderung beider Füße für Berührung und Vibration (Stimmgabel 3/8 beidseits am Großzehengrundgelenk), abgeschwächte Achillessehnenreflexe beidseits, unsicherer Zehen- und Fersengang, positives Romberg-Zeichen bei Augenschluss. Kein Absinken im Arm- und Beinvorhalteversuch, keine Paresen der großen Muskelgruppen. Im Praxisflur verlangsamtes, vorsichtiges Gangbild ohne Hilfsmittel, kleinschrittig, mit Blick auf den Boden.

Elektro-neurographie vom 08.06.2026

Die Nervenleitgeschwindigkeit des Nervus suralis ist beidseits deutlich reduziert, die Amplituden sind erniedrigt; motorisch zeigt der Nervus peroneus rechts eine grenzwertige Latenzverlängerung. Der Befund ist mit einer sensomotorischen Polyneuropathie vereinbar, die Konstellation spricht für eine diabetische Genese.

Beurteilung und Empfehlung

Es besteht eine klinisch und elektrophysiologisch gesicherte diabetische sensomotorische Polyneuropathie mit Gangunsicherheit und neuropathischem Schmerzsyndrom. Ich empfehle die Optimierung der Diabeteseinstellung, Podologie, die Fortführung der Schmerztherapie mit Pregabalin (Dosiserhöhung auf zweimal 75 mg bis 150 mg möglich) sowie die Prüfung eines Gehstocks zur Sturzprophylaxe.

Für die sozialmedizinische Bewertung erlaube ich mir den Hinweis, dass Gangunsicherheit und neuropathischer Schmerz nicht getrennt von der COPD und der Gonarthrose bewertet werden sollten; die Beeinträchtigungen verstärken sich beim Gehen wechselseitig.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med. Aylin Stern

Pneumologischer Befundbericht

Pneumologiezentrum Münster

Dr. med. Jörn Hachtkemper, Dr. med. Claudia Wesselmann

Fachärzte für Innere Medizin und Pneumologie

Weseler Straße 253, 48151 Münster

Telefon 0251 77 40 91-0

Münster, den 18.05.2026

Befundbericht Helga Bertram, geboren am 22.05.1964, Untersuchung am 16.05.2026

Diagnose

COPD Gold II, Gruppe B. Ex-Raucherin seit 2022, zuvor etwa 25 Packungsjahre. Belastungsdyspnoe mMRC 2 bis 3.

Lungenfunktion vom 16.05.2026

FEV1 58 Prozent des Sollwertes (1,52 Liter), FEV1/FVC 61 Prozent, geringe Reversibilität nach Bronchospasmolyse (plus 6 Prozent). Residualvolumen mäßig erhöht als Hinweis auf Überblähung. Sauerstoffsättigung in Ruhe 95 Prozent.

Sechs-Minuten-Gehtest vom 16.05.2026

Gehstrecke 298 Meter. Abbruch nach sechs Minuten wegen Atemnot und brennender Fußschmerzen. Sättigungsabfall unter Belastung auf 91 Prozent, Erholung in Ruhe innerhalb von vier Minuten. Borg-Dyspnoe am Testende 6 von 10. Die Patientin machte während des Tests zwei kurze Stehpausen.

Therapie und Verlauf

Duale Bronchodilatation mit LABA/LAMA-Fixkombination, Salbutamol als Bedarfsspray. Atemphysiotherapie wurde empfohlen, ein Rezept ist ausgestellt. Eine Indikation für eine Langzeitsauerstofftherapie besteht derzeit nicht. Im Vergleich zur Voruntersuchung von September 2024 (FEV1 damals 66 Prozent Soll, Gehstrecke 385 Meter) ist die Belastbarkeit deutlich reduziert. Die Patientin berichtet, Treppen in den ersten Stock nur noch mit Pause zu schaffen; bei feuchtwarmer Witterung und in der Dampfatmosphäre ihrer Küchentätigkeit verstärkte sich die Luftnot.

Beurteilung

Mittelgradige, im Verlauf zunehmende obstruktive Ventilationsstörung mit relevanter Einschränkung der Belastbarkeit. Der Sechs-Minuten-Gehtest ist durch die Kombination aus Dyspnoe und neuropathischen Fußschmerzen limitiert; die pneumologische Komponente allein erklärt die kurze Gehstrecke nicht vollständig, trägt aber wesentlich bei. Wiedervorstellung in sechs Monaten oder bei Verschlechterung vereinbart.

Dr. med. Jörn Hachtkemper

Arbeitsplatznotiz der Teamleitung

Schulverpflegung Westfalen gGmbH

Betriebsstätte Schulzentrum Hiltrup

Westfalenstraße 199, 48165 Münster

Teamleitung: Petra Vennemann

Interne Notiz vom 27.06.2026, auf Bitte von Frau Bertram für deren Rechtsanwältin erstellt

Tätigkeit

Frau Helga Bertram ist seit August 2014 bei uns als Küchenhilfe beschäftigt, derzeit mit 24 Wochenstunden, Montag bis Freitag von 9:00 bis etwa 13:45 Uhr. Sie arbeitet im Wechsel in der Spülküche und an der Essensausgabe. Zum Aufgabenbild gehören außerdem das Auffüllen der Ausgabetheken, Wege zwischen Lager, Küche und Ausgabe sowie das Bereitstellen von Getränken.

Beobachtungen seit Frühjahr 2026

Seit dem Frühjahr 2026 kann Frau Bertram Getränkekisten nicht mehr tragen; das übernehmen inzwischen die Kolleginnen. Sie bittet häufiger um Sitzpausen, die wir ihr außerhalb der Stoßzeit ermöglichen. Die Wege zwischen Lager und Ausgabe dauern bei ihr spürbar länger als früher. Für die Treppe zum Kellerlager wird sie seit April 2026 nicht mehr eingeteilt, nachdem sie zweimal auf halber Treppe stehen geblieben war und sich am Geländer festgehalten hat. Stehen über etwa 30 Minuten führt zu sichtbaren Schmerzen; sie verlagert dann ständig das Gewicht und stützt sich an der Arbeitsfläche ab. In der Spülküche klagt sie bei hoher Luftfeuchtigkeit über Atemnot; wir tauschen sie dann an die Ausgabe.

Einsatzfähigkeit und Ausfälle

Wir versuchen, Frau Bertram weiter einzusetzen, weil sie zuverlässig und bei den Schülern beliebt ist. Eine dauerhafte Reduzierung auf reine Kassentätigkeit ist organisatorisch nicht möglich, weil alle Küchenhilfen im Rotationsprinzip arbeiten müssen. Krankheitsbedingte Ausfälle im Jahr 2026 bisher: 21 Arbeitstage (Stand 27.06.2026), davon zusammenhängend 9 Arbeitstage im Februar nach einem Atemwegsinfekt.

Diese Notiz gebe ich nach bestem Wissen; eine arbeitsmedizinische Bewertung ist damit nicht verbunden.

Petra Vennemann

Teamleitung

Alltagsprotokoll Gehfähigkeit

aufgeschrieben von Helga Bertram auf Bitte der Kanzlei, abgegeben am 01.07.2026

12.06.2026: Weg zur Bushaltestelle Marktallee, laut Handy 380 Meter. Nach etwa 250 Metern Pause an der Gartenmauer von Nummer 8, Füße brennen, rechte Wade krampft. Bus fast verpasst, der Fahrer hat gewartet.

14.06.2026: Einkauf im Supermarkt, Einkaufswagen als Stütze genommen. Nach 20 Minuten Atemnot, an der Kasse auf die Fensterbank gesetzt, die Kassiererin hat gefragt, ob sie jemanden rufen soll. Zu Hause eine Stunde mit hochgelegten Beinen auf dem Sofa.

18.06.2026: Treppe zu meiner Schwester im zweiten Stock nicht geschafft. Nach dem ersten Stock Pause auf dem Treppenabsatz, dann ist sie zu mir heruntergekommen. Wir haben im Hausflur gesessen.

22.06.2026: Arbeit in der Kantine, Spüldienst nach 35 Minuten mit Gabi getauscht, weil die Füße nicht mehr wollten. Frau Vennemann hat gesagt, ich solle bloß nicht wieder stürzen wie im April.

26.06.2026: Bescheid noch einmal gelesen. Ich verstehe nicht, warum die Lunge und die Füße einzeln so klein gerechnet werden, wenn doch beides zusammen beim Gehen kommt. Angst, die Arbeit nicht bis zur Rente zu schaffen.

28.06.2026: Sonntagsspaziergang mit meinem Mann versucht, bis zur Kirche und zurück, das sind hin und zurück ungefähr 700 Meter. Zwei Pausen auf der Bank am Kirchplatz, auf dem Rückweg noch eine an der Bäckerei. Mein Mann sagt, ich sei früher doppelt so schnell gegangen.

30.06.2026: Termin beim Fußpfleger abgesagt, weil kein Auto da war und ich die Strecke (laut Karte 900 Meter) nicht zu Fuß schaffe. Neuer Termin erst am 15.07.

Widerspruch gegen den Bescheid vom 21.06.2026

Kanzlei Terwiel & Brandhove Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte PartG mbB

Salzstraße 21, 48143 Münster

Telefon 0251 41 88 02-0, Telefax 0251 41 88 02-29

Rechtsanwältin Dr. Sabine Terwiel, Fachanwältin für Sozialrecht

An die

Stadt Münster

Amt für Soziales und Wohnen

Sachgebiet Schwerbehindertenrecht

Hafenstraße 8

48153 Münster

vorab per Telefax

Münster, den 03.07.2026

Unser Zeichen: 2026-0412-SB/te

Ihr Geschäftszeichen: 50.33-SB-2021-004718

In der Schwerbehindertenangelegenheit Helga Bertram, geboren am 22.05.1964, Zum Roten Berge 14, 48165 Münster

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass uns Frau Helga Bertram mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat. Eine auf uns lautende Vollmacht ist beigelegt. Namens und in Vollmacht unserer Mandantin legen wir gegen den Bescheid vom 21.06.2026, zugegangen am 25.06.2026, Widerspruch ein.

1 Begründung

Der Bescheid bewertet die Funktionsbeeinträchtigungen unserer Mandantin nicht zutreffend. Es geht nicht um eine bloße Addition einzelner Diagnosen, sondern um die Gesamtwirkung aus diabetischer Polyneuropathie, COPD, Gonarthrose rechts und der dämpfenden Schmerzmedikation. Diese Gesamtwirkung ist im Bescheid nicht erkennbar gewürdigt.

Unsere Mandantin ist in ihrer Gehfähigkeit erheblich eingeschränkt. Der pneumologische Sechs-Minuten-Gehtest vom 16.05.2026 ergab eine Gehstrecke von lediglich 298 Metern mit Abbruch wegen Atemnot und Fußschmerzen sowie einem Sättigungsabfall auf 91 Prozent. Der neurologische Bericht vom 10.06.2026 beschreibt eine elektrophysiologisch gesicherte sensomotorische Polyneuropathie mit Gangunsicherheit, Sensibilitätsminderung und neuropathischem Schmerzsyndrom; am 18.04.2026 kam es zu einem Sturz auf öffentlichem Gehweg. Die Arbeitgeberin bestätigt erhebliche Einschränkungen beim Stehen, Tragen, Gehen und Treppensteigen bis hin zur Herausnahme aus der Einteilung für das Kellerlager.

Die Bewertung im Bescheid beruht ersichtlich auf kurzen Befundantworten; die aktuelle Lungenfunktion vom 16.05.2026 und die Elektroneurographie vom 08.06.2026 sind darin noch nicht berücksichtigt.

2 Anträge

2.1 Es wird beantragt, den Bescheid vom 21.06.2026 aufzuheben und bei unserer Mandantin einen GdB von mindestens 50 festzustellen.

2.2 Es wird weiter beantragt, die gesundheitlichen Voraussetzungen des Merkmals G festzustellen, hilfsweise eine erneute versorgungsärztliche Begutachtung mit persönlicher Untersuchung durchzuführen.

2.3 Es wird Akteneinsicht nach § 25 SGB X beantragt, insbesondere in die versorgungsärztliche Stellungnahme und die eingeholten Befundantworten.

3 Anlagen und weitere Begründung

Beigefügt sind der Befundbericht des Hausarztes Dr. Büscher vom 28.06.2026, der neurologische Bericht der Frau Dr. Stern vom 10.06.2026 und der pneumologische Befundbericht des Pneumologiezentrums Münster vom 18.05.2026. Ein orthopädischer Befundbericht ist angefordert und wird nachgereicht. Nach Gewährung der Akteneinsicht bleibt eine ergänzende Begründung ausdrücklich vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sabine Terwiel

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht

Anlagen: Vollmacht, Befundberichte (3)

Befundanforderungsliste

Interner Arbeitszettel, Az. 2026-0412-SB/te, angelegt am 01.07.2026, zuletzt geändert am 08.07.2026. Schweigepflichtentbindungen für alle Behandler liegen seit dem 01.07.2026 unterschrieben vor.

Anforderungen

Hausarzt Dr. Büscher: vollständige Diagnosenliste, Medikamentenplan, Diabetesverlauf mit HbA1c-Werten, Dokumentation der Sturzereignisse. Angefordert am 01.07.2026, eingegangen am 29.06.2026 (Bericht war auf Bitte der Mandantin bereits vorab erstellt).

Neurologie Dr. Stern: Elektroneurographie, Gangprüfung, Schmerzmedikation, Prognose. Bericht vom 10.06.2026 lag bei Mandatserteilung vor; Ergänzungsfragen zurückgestellt.

Pneumologiezentrum Münster: Lungenfunktion, Sechs-Minuten-Gehtest, mMRC-Einstufung, Therapieplan, Vergleich zur Voruntersuchung 2024. Bericht vom 18.05.2026 liegt vor.

Orthopädie Dr. Kleffner und Dr. Sowa: Gonarthrose rechts, Wirbelsäule, Geh- und Stehfähigkeit, Röntgenbefunde. Angefordert am 01.07.2026, Bericht vom 08.07.2026 eingegangen.

Arbeitgeberin Schulverpflegung Westfalen gGmbH: konkrete Tätigkeiten, Ausfallzeiten, Anpassungen, Treppen/Lager/Spüldienst. Notiz der Teamleitung vom 27.06.2026 liegt vor.

Mandantin: Wegeprotokoll (liegt vor, abgegeben 01.07.2026), Nachweis des Sturzes vom 18.04.2026 (hausärztlich dokumentiert), Fahrkarten oder Taxiquittungen für vermiedene Fußwege (Mandantin sucht Belege heraus), Fotos von Hilfsmitteln entfallen, da bislang kein Hilfsmittel genutzt wird.

Noch offen

Ergebnis der Akteneinsicht auswerten, sobald die Verwaltungsakte übersandt ist; danach entscheiden, ob eine ergänzende neurologische Stellungnahme zur Gehstrecke eingeholt wird.

Vermerk Klagestrategie Sozialgericht

Interner Vermerk, Az. 2026-0412-SB/te, Dr. Terwiel, 16.07.2026 — nur für die Handakte

Ausgangslage nach Akteneinsicht

Die versorgungsärztliche Stellungnahme vom 12.06.2026 bewertet nach Aktenlage: Diabetes mit Polyneuropathie Einzel-GdB 30, Wirbelsäule 10, Kniegelenk 10, Atemwege 10, Gesamt-GdB 30. Die aktuelle Lungenfunktion vom 16.05.2026 und die Elektroneurographie vom 08.06.2026 lagen dem versorgungsärztlichen Dienst nicht vor; die Befundantwort des Hausarztes datiert vom 28.04.2026 und ist knapp gehalten. Genau hier setzt die ergänzende Widerspruchsbegründung an. Bleibt der Widerspruch dennoch erfolglos, gilt für die Klage:

Stoßrichtung der Klage

Die Klage muss die Teilhabewirkung konkret beschreiben, nicht die Diagnosen wiederholen. Schwerpunkt ist die Gehfähigkeit: Weg zur Arbeit, Supermarkt, Treppen, Pausenbedarf, Sechs-Minuten-Gehtest mit 298 Metern, Sturz vom 18.04.2026 und die Arbeitsplatzanpassungen (kein Kellerlager, kein Kistentragen, Sitzpausen). Für das Merkzeichen G sind die tatsächlichen Einschränkungen bei üblichen Wegen im Ortsverkehr präzise darzustellen; das Alltagsprotokoll der Mandantin liefert dafür die Einzelbeobachtungen mit Datum und Metern.

Zu erwarten ist der Einwand, die Gehtestergebnisse seien durch die Mischung aus Atemnot und Fußschmerz nicht eindeutig einer Funktionsstörung zuzuordnen. Darauf ist zu antworten, dass es für die Gesamtbewertung wie für das Merkzeichen G auf das tatsächliche Gehvermögen ankommt, gleich aus welcher der festgestellten Gesundheitsstörungen die Einschränkung gespeist wird. Der Hinweis der Neurologin, die Beeinträchtigungen verstärkten sich wechselseitig, trägt diese Argumentation.

Beweismittel

Versorgungsärztliche Stellungnahme inhaltlich angreifen: Bewertung nach Aktenlage, veraltete und unvollständige Befundgrundlage.

Behandelnde Ärzte (Büscher, Stern, Hachtkemper) als sachverständige Zeugen benennen.

Einholung eines Gutachtens nach § 106 SGG anregen, internistisch-neurologisch mit Gehstreckenprüfung; falls das Gericht zögert, Antrag nach § 109 SGG mit der Mandantin besprechen (Kostenvorschuss erläutern).

Arbeitgeberin (Teamleiterin Vennemann) als Zeugin für Steh- und Gehprobleme am Arbeitsplatz.

Parallelthema Rente

Parallel im Blick behalten: Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die Mandantin (Jahrgang 1964) profitiert nur, wenn der GdB 50 rechtzeitig vor dem geplanten Rentenbeginn festgestellt wird. Das spricht dagegen, das Widerspruchsverfahren durch immer neue Nachreichungen zu strecken; lieber zügig entscheiden lassen und notfalls klagen.

Akteneinsicht: Übersendungsschreiben und versorgungsärztliche Stellungnahme

Übersendungsschreiben der Stadt Münster

Stadt Münster

Amt für Soziales und Wohnen

Sachgebiet Schwerbehindertenrecht

Hafenstraße 8, 48153 Münster

Geschäftszeichen: 50.33-SB-2021-004718

Sachbearbeitung: Frau Kottrup

Münster, den 14.07.2026

An die

Kanzlei Terwiel & Brandhove

Salzstraße 21

48143 Münster

Widerspruchsverfahren Helga Bertram; Ihr Schreiben vom 03.07.2026; Akteneinsicht

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Dr. Terwiel,

der Eingang Ihres Widerspruchs vom 03.07.2026 wird bestätigt. Dem Antrag auf Akteneinsicht wird in der Weise entsprochen, dass wir Ihnen anliegend Kopien der versorgungsärztlichen Stellungnahme vom 12.06.2026 sowie der eingeholten Befundantworten übersenden. Die von Ihnen nachgereichten Befundberichte haben wir dem versorgungsärztlichen Dienst zur erneuten Prüfung zugeleitet. Über den Widerspruch wird nach Abschluss dieser Prüfung entschieden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Kottrup

Anlage: Versorgungsärztliche Stellungnahme vom 12.06.2026

Versorgungsärztlicher Dienst der Stadt Münster

Stellungnahme nach Aktenlage

Dr. med. Renate Gellrich, Fachärztin für Innere Medizin, Sozialmedizin

Betrifft: Bertram, Helga, geboren am 22.05.1964; Neufeststellungsantrag vom 04.03.2026

Ausgewertet wurden: Befundantwort Dr. Büscher vom 28.04.2026, Befundantwort Dr. Stern vom 05.05.2026 (Kurzform), Befundbericht Orthopädie aus dem Vorverfahren 2021, Eigenangaben der Antragstellerin im Antragsformular.

Bewertung der Funktionsbeeinträchtigungen nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen:

Der Diabetes ist insulinbehandelt; gravierende Einschnitte in der Lebensführung im Sinne der Grundsätze sind aus den Befundantworten nicht ableitbar. Die Polyneuropathie ist in der Befundantwort des Hausarztes als "zunehmend" beschrieben, objektivierende Messwerte liegen nicht bei. Zur

Atemwegserkrankung wird eine COPD genannt; aktuelle Lungenfunktionswerte sind nicht mitgeteilt, sodass von einer leichtgradigen Einschränkung auszugehen ist. Die Kniegelenks- und Wirbelsäulenbeschwerden sind ohne Hinweis auf höhergradige Bewegungseinschränkungen geblieben.

Der Gesamt-GdB beträgt unter Berücksichtigung der wechselseitigen Auswirkungen weiterhin 30. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr ist nach Aktenlage nicht hinreichend belegt; eine Gehstreckenmessung liegt nicht vor. Merkzeichen G: Voraussetzungen nicht erfüllt.

Eine persönliche Untersuchung wurde nicht für erforderlich gehalten. Bei Vorlage aktueller fachärztlicher Befunde, insbesondere einer Lungenfunktionsprüfung und einer neurologischen Objektivierung, wird um erneute Vorlage gebeten.

gez. Dr. Gellrich

Funktionsbeeinträchtigung	Einzel-GdB
Diabetes mellitus mit Polyneuropathie	30
Funktionsbeeinträchtigung der Wirbelsäule	10
Funktionsbeeinträchtigung des rechten Kniegelenks	10
Atemwegsbeschwerden	10

Orthopädischer Befundbericht

Orthopädische Gemeinschaftspraxis

Dr. med. Ansgar Kleffner, Dr. med. Katarzyna Sowa

Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie

Hammer Straße 118, 48153 Münster

Telefon 0251 52 30 77-0

Münster, den 08.07.2026

An die

Kanzlei Terwiel & Brandhove

Salzstraße 21

48143 Münster

Befundbericht Helga Bertram, geboren am 22.05.1964, auf Ihre Anforderung vom 01.07.2026;
Schweigepflichtentbindung liegt vor

Sehr geehrte Damen und Herren,

Frau Bertram ist seit 2019 in unserer Behandlung, zuletzt vorgestellt am 30.06.2026.

Diagnosen

Gonarthrose rechts, Kellgren-Lawrence Grad III (Röntgen vom 30.06.2026), mit rezidivierender Reizerguss-Bildung nach Belastung.

Chronisches Lumbalsyndrom bei Osteochondrose L4/L5 und Spondylarthrose, ohne radikuläre Symptomatik.

Befund vom 30.06.2026

Rechtes Kniegelenk: Beugung/Streckung 0-0-110 Grad, medialer Gelenkspaltdruckschmerz, geringer Erguss, Krepitation. Die Patientin berichtet Anlaufschmerz und Belastungsschmerz nach etwa 15 Minuten Stehen oder 300 Metern Gehen. Lendenwirbelsäule: Finger-Boden-Abstand 24 cm, paravertebraler Hartspann, Zeichen nach Lasègue beidseits negativ. Das Gangbild ist rechtsseitig schonhinkend, ohne Hilfsmittel, verlangsamt.

Beurteilung der Geh- und Stehfähigkeit

Aus orthopädischer Sicht ist die Steh- und Gehbelastbarkeit relevant gemindert. Die Gonarthrose limitiert längeres Stehen und Treppensteigen; das Treppabgehen ist schmerzführend. Zusammen mit der uns aus den Vorbefunden bekannten Polyneuropathie ergibt sich eine deutlich sturzgefährdete Gangsituation. Eine Versorgung mit einer entlastenden Knieorthese wurde verordnet, ferner Krankengymnastik. Eine Endoprothese ist derzeit nicht indiziert, wird aber bei Progredienz in den nächsten Jahren zu diskutieren sein.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Ansgar Kleffner